

Información Paciente

Nombre : Carlos Del Carmen Reyes Reyes

Rut : 6.084.508-5

N° Archivo : 1328922

N° Epicrisis

407858

Edad : 72a 3m 9d

Fecha Nacto: 18/04/1952

Sexo : Masculino

Dirección : Pje Cerro Arenales 01436 Cerrito Arriba

Comuna : Puente Alto

Teléfono : 9 6229 7066

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Geriatria

Fecha Ingreso : 20/07/2024 16:25

Días Estadía: 7

Unidad de Egreso : Geriatria

Fecha Egreso : 27/07/2024 12:07

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Derivado de CDT Hepatología por desfuncionalizacion

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EGRESO UNIDAD DE GERIATRÍA

Nombre: Carlos del Carmen Reyes Reyes

Edad: 72 años

RUT: 6.084.508-5

Dirección: Pasaje Cerro Arenales 1436 Pte Alto

Teléfono tutor: 62297066

Nombre Tutor: Jessica Reyes, hija

Datos obtenidos de: hija

Fecha de Ingreso a CASR: 20/07/24

Fecha de ingreso UGA: 20/07/24

ANTECEDENTES

BIOMÉDICO: Mórbitos: DHC obs secundario a NASH con Hepatocarcinoma (quimioembolización 2020 y 2021, Trasplante hepático 23/02/2023). DM2 con DOB (retinopatía diabética). HTA. ACV isquémico territorio ACM izquierda marzo 2022 - sin secuelas, HDA- úlcera duodenal Forrest III (mayo 2024), rosácea, adenoma paratiroideo hiperfuncionante, Herpes Zoster diciembre 2023 (dorso, pecho, brazo izquierdo), muy doloroso, quiebre funcional tras eso.

Fármacos: Tacrolimus 0.5 mg c/12 hrs, Micofenolato 500 mg cada 12 hrs, Trayenta 5 mg c/24 hrs, Amlodipino 5 mg c/24 hrs, Esomeprazol 40 mg c/24 hrs VO, Losartán 50 mg cada 12 hrs, Cinacalcet 300 mg al almuerzo, atorvastatina 20 mg/día, Citalopram 20 mg/día /// Pregabalina hasta 300 mg/día + tramadol, suspendido hace un mes por desorientación (disminucion paulatina), indicado tras herpes zoster.

Adherencia y administración buena adherencia, manejados por hija.

Antecedentes quirúrgicos: transplante hepático

Nutricional: Cambio de peso: baja de peso marcada, subjetiva, desde hace 5 meses. Apetito disminuido. Peso antes de transplante 85 kg. Apetito: muy disminuido desde hace 5 meses, acentuado desde hospitalización. Consistencia papilla y líquido. Disfagia: niega

Alergias: (-)

Hábitos : Tabaco: suspendido a los 20 años, OH: suspendido a los 20 años, Drogas: no

Inmunizaciones: Influenza 2024(-) - Covid 3 dosis - Neumo (-)

Hospitalizaciones previas: HDA mayo 2024

Fecha Epicrisis : 27/07/2024 12:19

FUNCIONAL: ABVD dependencia total, Barthel: 15/100. Comer: dependiente por temblor. Usar retrete: dependiente. Deposiciones: continente, usa baño portátil. Micción: incontinencia, aprox 1 episodio al día cuando no le alcanzan a poner pato. Lavarse: aseo en cama, desde hace un mes que no lo pueden bañar. Arreglarse: dependiente. Vestirse: dependiente. Traslados: dependiente. Deambulaci3n: no. Escaleras: no. Dependencia total AIVD Lawton: 0/8. Quiebre funcional progresivo desde diciembre 2023 tras cuadro de Herpes Zoster, acompa1ado de deterioro cognitivo agudo tambi3n progresivo, acentuado tras 3ltima hospitalizaci3n en mayo por HDA. Previamente (noviembre 2023) era independiente en ABVD y AIVD (con sesgo de g3nero Ly B 5/ 8), vivía solo con esposa, sin conflictos. Ayudas t3cnicas: ba1o portátil y un bast3n canadiense que no usa hace a1os. Silla de ruedas prestada. Caídas el 3ltimo a1o: 6 caídas en los 3ltimos 4 meses, 3ltima caída hace 2 semanas al intentar levantarse al ba1o. Lentes 3pticos: usa, correcci3n parcial. Prótesis dental: superior

COGNITIVO/MENTAL: Escolaridad: media completa, cursos posteriores (reanimaci3n, rescate). Ocupaci3n previa: inspector municipal, jubil3o hace 4 a1os. Lectoescritura conservada hasta hace 3 meses. Cognitivamente sin conflicto hasta Diciembre 2023 seg3n lo descrito por la hija. Desde que tuvo Herpes Zoster (diciembre 2023), tuvo declive cognitivo progresivo intensificado tras 3ltima hospitalizaci3n (en un inicio m3s apático, menos participativo, desde hace 3 meses con desorientaci3n fluctuante, hay días en que no reconoce a hijos ni esposa). Aparentemente estudiado en neurología extrasistema que lo atribuye a tratamiento farmacol3gico (redsalud), se suspendió pregabalina y tramadol, sin cambios. Sin trastorno del sue1o, en ocasiones somnolencia marcada durante el día, pero siempre logra dormir en la noche. Hija sospecha trastorno del ánimo por retraimiento de los 3ltimos meses. No ha tenido conflictos familiares ni duelos recientes.

SOCIAL: Estado civil/Hijos/Cuidado: viven en casa de 2 pisos en puente alto, casa propia. Vive con esposa, hija y familia de la hija. Tiene 3 hijos, apoyo de todos. Hija hace 5 meses se tuvo que ir a vivir con ellos , y renu nciar a su trabajo.

CUADRO CLÍNICO: Paciente con antecedentes descritos, es derivado desde CDT Hepatología para estudio. Paciente hasta hace 8 meses (noviembre 2024) independiente en ABVD y AIVD, aparentemente sin deterioro cognitivo. Desde Diciembre 2023, tras cuadro de Herpes Z3ster diseminado (t3rax, brazo izquierdo), con dolor neuropático intenso asociado, present3o un declive cognitivo y funcional progresivo, acentuado tras hospitalizaci3n en mayo por HDA. En un inicio m3s apático y retraído, menos participativo, posteriormente y desde hace 3 meses con episodios fluctuantes de desorientaci3n, en ocasiones no reconoce a familiares, habla incoherente, hay días enteros en que no emite lenguaje. En lo funcional, declive progresivo desde diciembre, en un inicio atribuido al dolor por Herpes Z3ster, acentuado tras 3ltima hospitalizaci3n hasta dependencia total en ABVD. Solo preserva continencia de deposiciones. Fue evaluado por Neurología en extrasistema, aparentemente atribuyen cuadro a fármacos, se suspende pregabalina y tramadol, y se inicia Citalopram, pero sin presentar mejoría. Del laboratorio tomado en CDT, sin alteraciones significativas. Ingresa a UGA para estudio.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO:

Biomédico:

Obs. Demencia rápidamente progresiva

AKI sobre ERC etapa IV (crea basal 1.9)

Hiponatremia leve con VEC disminuido

Hiperparatiroidismo primario

· Adenoma paratiroideo hiperfuncionante

5. Hipercalcemia moderada en tratamiento

6. Desnutrici3n calorico-proteica

7. Trasplante hepático 02/2023 (DHC + HCC)

8. Inmunosupresi3n secundaria a fármacos

9. Antec: DM con DOB, HTA, HDA- úlcera duodenal Forrest III mayo 2024

Sd. Geriátricos: fragilidad, sarcopenia, dismovilismo, polifarmacia, tr del ánimo, Sd. de caídas, constipaci3n, baja de peso, déficit sensorial visual, incontinencia urinaria.

Funcional: Dependencia total ABVD Barthel 15/100 | Dependencia total AIVD

Cognitivo: Deterioro cognitivo en estudio

Social: Red social presente y efectiva.

EVOLUCIÓN EN UGA:

-Hemodinamia/CV: permanece con hemodinamia estable, autosostenida, normotenso, normocárdico, no requiere antihipertensivos, mantiene tromboprofilaxis. Inicialmente VEC disminuido, recibe volemicaci3n bien tolerada. Padua 4 pts, recibe tromboprofilaxis sin incidentes. Sin evidencia de sangrados, sin requerimiento transfusional No es conflicto.

-Neurología: ingresa para estudio por sospecha de demencia rápidamente progresiva, con antecedente de ACV en 2022 ese entonces ya evidenciaba lesiones en sitio estratégico y daño microangiopático bilateral. Actualmente con historia de deterioro cognitivo progresivo desde 12/2023 con quiebre funcional. Es evaluado por neurología quienes descartan necesidad de PL y sugieren realizar AngioTC cerebro-cuello y RM cerebral sin gadolinio (informe abajo), con dichos resultados se indica que no se observa elementos sugerentes de vasculitis SNC, impresiona gran carga microvascular de s blanca por F de R CV clásicos, cin infartos agudos nuevos, sin elementos de autoinmunidad o priones, más probable demencia vascular + toxicometabólico (en particular por el uso de Tacrolimus como Micofenolato, en quienes está descrito leucoencefalopatía tóxica, pero de perfil más agudo con restricción de DWI, elemento que no tiene actualmente). Dado que imagen no tiene Gad, se sugiere realizar PL solo con citoquímico, ADA, cultivo corriente y gram, para identificar si hay algún componente inflamatorio/tipo paraneoplásico. Ac paraneoplásicos en sangre a UC. Sugieren carga de vitamina D y control ambulatorio. No se logra concretar la realización de PL, sin embargo, ésta no es impedimento para egreso hospitalario. Con indicación de mantener atorvastatina, pero por desnutrición y fragilidad avanzada, disminuyo dosis. Al alta derivar a neurología.

-Gastroenterología: evaluado por especialista en trasplante hepático, sugiere plantear realización de Endoscopia Digestiva Alta, no se describe fin específico y por estado general del paciente se desestima. No modifica dosis de inmunosupresores por lo que se mantiene dosis actual de Tacrolimus 0.5 mg cada 12 horas. MMF 500 mg cada 12 h. Seguimiento ambulatorio.

Endocrinológico: antecedente de hiperparatiroidismo por adenoma hiperfuncionante, en controles con especialidad (último Junio 2023), con plan de manejo médico y control con eco cervical y cintigrama de paratiroides, ambos pendientes. En exámenes destaca hipercalcemia y PTH alta (ambos en valores similares a los descritos en ambulatorio). Dado hipercalcemia se mantiene con cinacalcet y volemicización ev con buena respuesta por lo que se suspende volemicización. Perfil tiroideo normal. HbA1C 5.8%, por fragilidad y dependencia de paciente meta terapéutica es 8%, por lo que no se reiniciara hipoglicemiante.

-Nefrológico/medio interno: Antecedente de ERC etapa IV, crea basal 1.9. Ingresa con AKI KDIGO 1 pre renal asociado a hiponatremia leve que corrige con volemicización ev, actualmente función renal en su basal, resto de electrolitos en rango, calcio normal, suspendo volemicización. No impresiona conflicto actual.

-Nutrición: Con desnutrición calórica - proteica, secundario a hipoingesta multifactorial. Tiene riesgo de sd. realimentación por lo que recibió tiamina endovenosa durante 5 días, sin incidentes. Se indica PEG al alte, regular para lograr deposiciones diarias. Funcional: paciente con quiebre funcional en los últimos 8 meses, actualmente dependencia total en ABVD. Seguimiento por equipo multidisciplinario con énfasis en prevención de complicaciones de dismovilismo, con mal pronóstico de rehabilitación. Se realiza IPD para AATT.

-Social: Red social presente y efectiva, destino al alta su domicilio.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS:

22/07/2024: Alb 3.6, Bt 0.78, ALP 105, GGT 157, TGO 33, TGP 34, Creat 1.70, BUN 30, Glucosa 76, Niveles B12 1462, Niveles de Vitamina D 19.7, Na 137, K 4.17. TSH y VDRL B12 normal.

23/07/2024: Niveles Tacrolimus: 6.2

24/07/2024: BT 0.53, ALP 83, GGT 122, TGO 42, TGP 32, Ca 10.5, Creat 1.78, BUN 20, Hb 10.6, Hcto 34.4, WBC 5150, Ne 60%, Pla 125000, Na 134, K 3.15.

26/07/2024: Hb: 10.6, Hto: 32.8%, Leucoc: 6160, Neut: 72.1%, Linfoc: 21.7%, RAN: 4.4, RAL: 1.3, Plq: 111.000. PCR: 11.3. Albúm: 2.7, Bun: 15.1, Creat: 1.45, Na: 136, K: 3.45, Cl: 108, Ca: 7.7, P: 2.0, Mg: 1.3. GSV: pH: 7.37, HCO3: 19.8

RM CEREBRO (22/07/2024): Infartos lacunares antiguos de sustancia blanca subcortical de ambos hemisferios cerebrales y talámicos bilaterales. Microhemorragias talámicas bilaterales. Microangiopatía confluyente de sustancia blanca supratentorial. Signos de leve pérdida difusa de volumen encefálico, sin un patrón característico.

TAC TAP (23/07/2024): Anomalía intersticiales pulmonares bilaterales, inespecíficas, sin cambios significativos con respecto a estudio previo. Acentuada aterosclerosis calcíca aortobílica y en territorio coronario. Ectasia fusiforme de aorta abdominal infrarrenal. Pequeña lesión quística en proceso uncinado del páncreas sin criterios tomográficos de agresividad, sin cambios.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO:

Biomédico:

Demencia vascular + toxicometabólico

· Uso tacrolimus y micofenolato

2. AKI sobre ERC etapa IV (crea basal 1.9) prerrenal recuperada

3. Hiponatremia leve con VEC disminuido, resuelta

Fecha Epicrisis : 27/07/2024 12:19

Página 3 de 5

Fecha Última Actualización: 27-07-2024 12:19:55

Página 4 de 5

4. Hiperparatiroidismo primario
 - Adenoma paratiroideo hiperfuncionante
 - Hipercalcemia moderada tratada
5. Desnutrición calorico-proteica
6. Trasplante hepático 02/2023 (DHC + HCC)
 - Inmunosupresión secundaria a fármacos
7. Antec: DM con DOB, HTA, HDA- úlcera duodenal Forrest III mayo 2024

Sd. Geriatricos: fragilidad, sarcopenia, dismovilismo, polifarmacia, tr del ánimo, Sd. de caídas, constipación, baja de peso, déficit sensorial visual, incontinencia urinaria.

Funcional:

Dependencia total ABVD B ar th el 1 5/ 100

Dependencia t ot al A IVD

Cognitivo:

Trastorno neurocognitivo mayor en rango moderado.

Demencia vascular + tóxicometabólica

Social: Red social presente y efectiva.

Diagnóstico de Egreso

DEMENCIA VASCULAR - Demencia vascular + tóxicometabólico

· Uso tacrolimus y micofenolato

Insuficiencia renal aguda, no especificada - 2. AKI sobre ERC etapa IV (crea basal 1.9) prerrenal recuperada

3. Hiponatremia leve con VEC disminuido, resuelta

HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO - 4. Hiperparatiroidismo primario

· Adenoma paratiroideo hiperfuncionante

· Hipercalcemia moderada tratada

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Pcte en buenas condiciones generales .Hemodinamia autosustentada, afebril , normocardico , normotenso.Sin apremio ventilatorio actual, sin requerimiento de O2. En su basal

Plan Post Alta

Reposo relativo, levantar todos los días

Cambios de posición c/3-4 horas.

Aseo ocular c/8 hrs. Aseo cavidad oral tres veces al día. Hidratar piel.

Regimen consistencia papilla + líquidos claros a tolerancia

Tacrolimus 0,5 mg cada 12 horas vía oral

Micofenolato 500 mg cada 12 horas vía oral

Citalopram 20 mg/ día vía oral

Cinacalcet 300 mg 1 comprimido al almuerzo + 1/2 comprimido en la cena

Atorvastatina 10 mg/día vía oral

PEG 17 gr cada 8 hrs vía oral, para lograr deposiciones diarias

Control Neurología (se entrega interconsulta)

Control Trasplante hepático

Control APS,Ingreso a Programa Dependencia Severa

Indicaciones

Tipo de Reposo : Reposo Relativo, Levantar Todos Los Días

Régimen Alimentario : Regimen Consistencia Papilla + Líquidos Claros A Tolerancia

Medicamentos :

Fecha Epicrisis : 27/07/2024 12:19

Página 4 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:58

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 27-07-2024 12:19:55

Página 5 de 5

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Jeniffer Alvarado Campoverde

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 27/07/2024 12:19

Página 5 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:58

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar